内科含诊断＋外科 消化性溃疡 & 消化道出血 ★★★（0~4题）

慢性、周期性 / 季节性、节律性上腹痛		
	胃溃疡	十二指肠溃疡（更多见）
节律性	餐后痛（进食→疼痛→缓解）（2021、2025）	饥饿痛（疼痛→进食→缓解）、夜间痛（2011、2021）“青年 12 点容易饿、吃了夜宵就缓解了”
Hp 感染	√	√
好发年龄	中老年	青壮年（2014）
好发部位	胃窦小弯侧（胃小弯角切迹）	球部前壁
发病机制	屏障功能减弱为主	侵袭因素增强为主

胃镜作为首选、金标准 —— 诊断消化性溃疡及并发出血 / 幽门梗阻 / 癌变、残胃癌（2011、2013、2014、2025）

上消化道出血最常见：消化性溃疡（40%~50%，2021）
上消化道出血次常见：门脉高压食管胃底曲张静脉破裂（20%~25%，2020、2021）

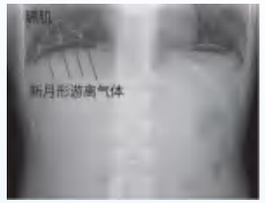
出血（最常见，2015）

- GU- 胃小弯，DU- 球部后壁（2012）
- 肠鸣音↑（2008）
- 粪隐血 -5ml、黑便 -50ml、呕血 -250ml、＞ 800~1000ml 可休克“一休哥”
  呕血或便血及颜色取决于速度（主要）、量（主要）、部位（2011、2015）
- 90% 通过保守治疗控制出血 ——
  ①休克：补充血容量（2014）
  ②未休克（2012、2013、2025）：
  内镜下仅见血凝块或溃疡不伴血迹：可仅用 PPI
  内镜下见活动性动脉出血或裸露血管：PPI+ 胃镜

并发症

- GU- 胃小弯，DU 急性 - 球部前壁（常见）、DU 慢性 - 球部后壁
- 突发上腹刀割样剧痛、腹膜刺激征（压痛 / 反跳痛 / 肌紧张呈板状腹）、以穿孔处最重（2026）
  肠鸣音↓、肝浊音界缩小消失（最有价值体征，2021）
  可有移动性浊音、可有转移性右下腹痛（2025）
  若上腹触及包块：胃肠内容物被包裹→穿刺置管引流（2016）
  若发热、右上腹痛、呃逆：膈下脓肿

穿孔



首选 X 线：膈下新月形游离气体（2017）
腹腔穿刺：抽出黄色浑浊含胆汁食物残渣

首先禁食补液、胃肠减压
饱餐后或弥漫性腹膜炎→修补缝合术（争取 8 小时内，2017）